



Détection concomitante de VZV dans le LCR au cours d'une méningite à *Klebsiella pneumoniae* : réactivation virale ou co-infection ?

Cas clinique

L.MERAANE^{1,2}, M. RAIS^{1,2}, I. KHARA¹, C. ABACHA¹, F. BOURAKBA¹, A. OUYAHIA^{1,2}
Service des maladies infectieuses CHU de Sétif ¹, faculté de médecine, université de Sétif, Algerie ²

Introduction :

Les méningites à *Klebsiella pneumoniae* sont exceptionnelles et surviennent préférentiellement chez les patients présentant des facteurs de risque tels que le diabète ou l'immunodépression. La positivité d'une PCR VZV dans le LCR peut compliquer l'interprétation diagnostique, en particulier lorsqu'elle coexiste avec un tableau de méningite bactérienne franche.

Observation :

Nous rapportons le cas d'un patient âgé de 24 ans , atteint de bêta-thalassémie majeure, diabétique sous insuline et splénectomisé, hospitalisé pour un sepsis sévère avec signes neurologiques évocateurs de méningite. La ponction lombaire a retrouvé un LCR purulent avec hypoglycorachie marquée, en faveur d'une méningite bactérienne. *Klebsiella pneumoniae* a été isolée dans le LCR. La PCR VZV réalisée sur le même échantillon s'est révélée positive à deux reprises. Le bilan étiologique a également mis en évidence une cholécystite alithiasique, considérée comme le foyer infectieux initial probable. Une antibiothérapie par un C3G adaptée à l'antibiogramme, associée à l'aciclovir, a été instaurée. L'évolution a été favorable sur les plans clinique et biologique.

Discussion :

Ce tableau oriente avant tout vers une méningite bactérienne franche à *Klebsiella pneumoniae* sur terrain à haut risque infectieux. La positivité répétée de la PCR VZV soulève la question d'une réactivation virale concomitante ou d'une détection fortuite. En l'absence d'arguments clinico-biologiques en faveur d'une atteinte virale, cette positivité doit être interprétée avec prudence avec la nécessité d'intégrer **Ct/charge virale**, recherche **d'anticorps intrathécaux**, pour guider la décision d'un traitement antiviral.

Conclusion :

Cette observation souligne l'importance d'une interprétation hiérarchisée des données cliniques, cytobiologiques et microbiologiques. Chez un patient immunodéprimé présentant un LCR purulent et une hypoglycorachie marquée, la méningite bactérienne doit rester l'hypothèse principale malgré une PCR virale positive.

Bibliographie :

Nagel MA, Gilden D. Neurological complications of varicella zoster virus reactivation. Curr Opin Neurol. 2014;27(3):356–360. DOI: 10.1097/WCO.0000000000000093
Leclercq I, Van Eldere J, et al. Clinical significance of varicella-zoster virus DNA detection in cerebrospinal fluid: review and recommendations. Clin Microbiol Infect. 2021;27(9):1203–1211. DOI: 10.1016/j.cmi.2021.03.004